Ruang Belajar Nadia

BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 12

Tinjauan Etik dan Hukum Kedokteran dalam Sistem Reproduksi: Kaidah Dasar Bioetik, Hak Reproduksi, Aborsi, dan Teknologi Reproduksi Berbantu

dr. Doby Indrawan, MMRS, FISPH, FISCM

Disusun dari PPT dosen "Etika dalam Sistem Reproduksi: Pendekatan Komprehensif Klinis, Legal, dan Bioetika" 2026 (dr. Doby Indrawan). Dilengkapi dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP No. 28 Tahun 2024 (pelaksana UU Kesehatan), UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru, berlaku 2 Januari 2026), UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 61 Tahun 2014 (aturan lama), Permenkes No. 290 Tahun 2008 (persetujuan tindakan kedokteran), Permenkes No. 43 Tahun 2015 (reproduksi berbantu), Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 2012, Beauchamp & Childress "Principles of Biomedical Ethics", dan WHO Abortion Care Guideline 2022. Gambar dari slide dosen.

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi

0.1 Isi kuliah

1. **Dasar**: apa itu etika, sistem reproduksi, kesehatan reproduksi, dan ruang lingkupnya.
2. **Alat berpikir**: **4 Kaidah Dasar Bioetik (KDB)** dan **hak reproduksi sebagai HAM**.
3. **Kasus besar 1, aborsi**: data, definisi klinis, legal vs ilegal, aturan lama vs baru (UU 17/2023, PP 28/2024, KUHP baru), sudut pandang etika Islam, syarat administratif, komplikasi aborsi tidak aman, dan contoh kasus.
4. **Kasus besar 2, teknologi reproduksi berbantu (ART)**: bayi tabung (IVF), surogasi, PGT, kloning, dan penyuntingan gen.
5. **Penutup**: solusi multipihak dan pesan bawa pulang.



Dari slide: judul kuliah "Etika dalam Sistem Reproduksi: Pendekatan Komprehensif Klinis, Legal, dan Bioetika" (dr. Doby Indrawan). *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

📖 **Kamus kecil**

Etika: prinsip moral tentang baik-buruk yang menuntun perilaku. **Bioetik / bioetika**: etika yang berkaitan dengan kehidupan, kedokteran, dan ilmu hayati. **Etikolegal**: gabungan sudut pandang etika (moral, profesi) dan hukum (undang-undang). **Medikolegal**: urusan kedokteran yang menyentuh hukum. **Malapraktik**: tindakan dokter yang menyimpang dari standar profesi dan menimbulkan kerugian pasien.

1. Fondasi Konseptual

1.1 Definisi (slide)

1. **Etika** (slide): **prinsip moral yang menuntun perilaku dan pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan reproduksi**.
2. **Sistem reproduksi** (slide): **sistem organ yang terlibat dalam fungsi reproduksi manusia**, termasuk **organ seksual, hormon, dan proses kehamilan**.
3. **Kesehatan reproduksi** (slide, definisi WHO yang dipakai juga di UU Kesehatan): **keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan**, yang berkaitan dengan **sistem, fungsi, dan proses reproduksi** pada **laki-laki dan perempuan**.

1.2 Lingkup (slide)

1. **Kesehatan reproduksi** secara umum.
2. **Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual**.
3. **Saat sebelum hamil (prakonsepsi), hamil, melahirkan, dan pascapersalinan**.





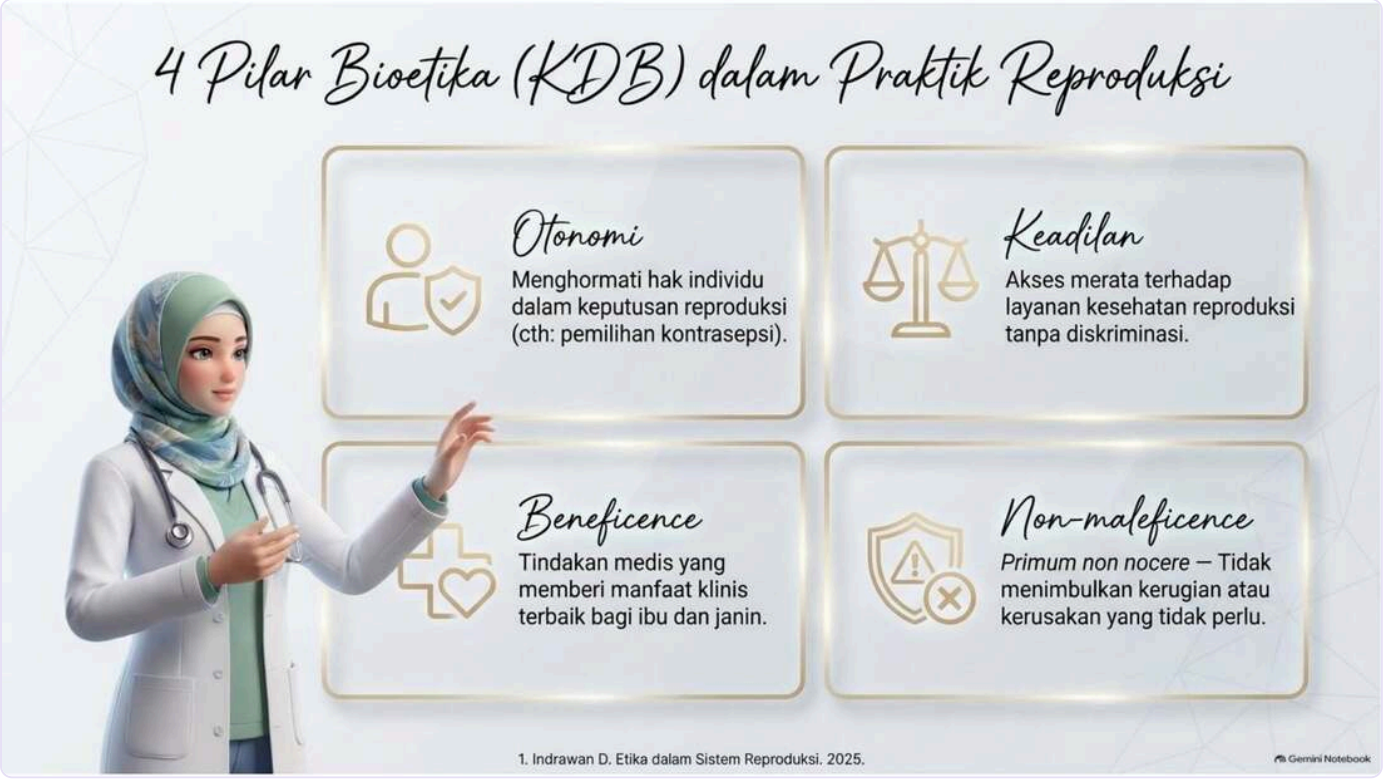
Dari slide. Kiri: definisi etika, sistem reproduksi, dan lingkup sistem reproduksi. Kanan: hubungan tiga konsep (etika, sistem reproduksi, kesehatan reproduksi) dengan lingkup utama prakonsepsi, hamil, persalinan, pascapersalinan, dan kontrasepsi. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

> ⭐ **Penting**
>
> Kesehatan reproduksi mencakup **sehat mental dan sosial**, bukan hanya organ. Karena itu keputusan reproduksi (hamil, KB, aborsi, bayi tabung) selalu menyentuh **psikologi, agama, budaya, dan hukum**, tidak cukup dilihat dari sisi medis saja.

2. Kaidah Dasar Bioetik (KDB)

2.1 Empat pilar (slide)

Kaidah	Arti (slide)	Contoh di bidang reproduksi
Otonomi (autonomy)	**Menghormati hak individu dalam keputusan reproduksi**	Pasien memilih sendiri metode kontrasepsi setelah dijelaskan; persetujuan tindakan (informed consent); menjaga rahasia
Beneficence (berbuat baik)	**Tindakan medis yang memberi manfaat klinis terbaik bagi ibu dan janin**	Merekomendasikan SC pada plasenta previa totalis; memberi MgSO4 pada preeklamsia berat
Non-maleficence (tidak merugikan)	**Primum non nocere: tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan yang tidak perlu**	Tidak melakukan episiotomi rutin; tidak melakukan tindakan di luar kompetensi
Keadilan (justice)	**Akses merata terhadap layanan kesehatan reproduksi tanpa diskriminasi**	Pelayanan ANC sama untuk pasien BPJS dan umum; distribusi bidan dan alat yang merata



Dari slide: empat pilar bioetika (Kaidah Dasar Bioetik) dalam praktik reproduksi, yaitu otonomi, keadilan, beneficence, dan non-maleficence. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

📖 **Kamus kecil**

Primum non nocere: bahasa Latin, "pertama-tama, jangan merugikan". **Paternalistik**: dokter memutuskan "demi kebaikan pasien" tanpa melibatkan pasien; bertentangan dengan otonomi bila dilakukan pada pasien dewasa yang kompeten. **Kompeten (secara hukum)**: dewasa (≥ 18 tahun atau sudah menikah), sadar, dan mampu memahami informasi.

2.2 Prima facie: bila kaidah bertabrakan

1. Keempat kaidah sama-sama penting, tetapi dalam kasus nyata sering **bertabrakan**. Misalnya ibu menolak SC (otonomi) padahal janin gawat (beneficence untuk janin).
2. **Prima facie**: dokter memilih **kaidah yang paling tepat untuk situasi itu**, dengan pertimbangan konteks. Pegangan umum yang dipakai di FK Indonesia:
    1. **Pasien dewasa, sadar, kompeten, informasi lengkap → otonomi** dihormati.
    2. **Gawat darurat, pasien tidak sadar / tidak kompeten → beneficence** (selamatkan nyawa dulu).
    3. **Tindakan berisiko tinggi atau tidak perlu → non-maleficence**.
    4. **Menyangkut banyak orang / sumber daya terbatas** (antrean ICU, wabah) **→ keadilan**.

2.3 Hak reproduksi sebagai hak asasi manusia (slide)

1. **Hak dasar** (slide):
    1. **Otonomi tubuh**: memutuskan sendiri apa yang terjadi pada tubuhnya.
    2. **Kesetaraan gender**: perempuan dan laki-laki setara dalam keputusan reproduksi.
    3. **Akses kesehatan memadai**: informasi dan layanan KB, ANC, persalinan aman.
2. **Perspektif multidisiplin** (slide):
    1. **Agama**: pandangan etis moral tentang keluarga dan aborsi.
    2. **Budaya**: tradisi yang membentuk norma etika masyarakat (misalnya "banyak anak banyak rezeki", larangan KB tanpa izin suami).
    3. **Hukum**: regulasi, kebijakan pemerintah, dan perlindungan hak.



Dari slide: hak reproduksi sebagai HAM. Kiri: hak dasar (otonomi tubuh, kesetaraan gender, akses kesehatan memadai). Kanan: perspektif agama, budaya, dan hukum yang perlu ditimbang bersamaan. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

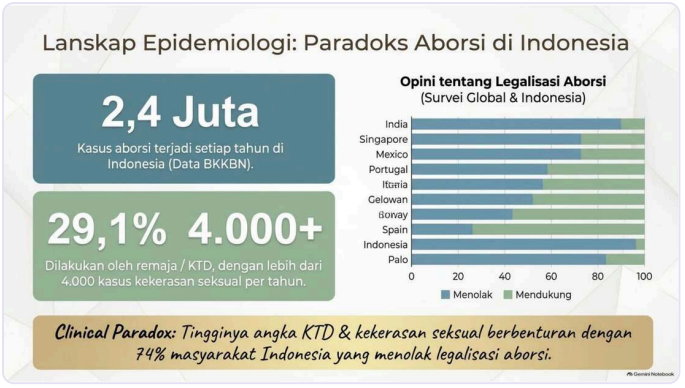
2.4 Penerapan sehari-hari (tambahan)

1. **Persetujuan tindakan kedokteran (informed consent)** (Permenkes 290/2008, UU 17/2023 Pasal 293):
    1. Isi penjelasan minimal: **diagnosis**, **tindakan dan tujuannya**, **alternatif**, **risiko dan komplikasi**, **prognosis**, dan **perkiraan biaya**.
    2. **Tertulis** untuk tindakan **berisiko tinggi** (operasi, kuretase, pemasangan implan/AKDR, sterilisasi); **lisan** cukup untuk tindakan ringan.
    3. Yang berhak memberi: **pasien sendiri bila kompeten**. Keluarga hanya bila pasien tidak kompeten. Pada keadaan **gawat darurat** untuk menyelamatkan nyawa, **tidak perlu persetujuan**, tetapi dijelaskan setelahnya.
2. **Kontrasepsi**: pasien dewasa berhak memilih metode; dokter memberi informasi lengkap (konseling **ABPK**), bukan memaksakan.
3. **Sterilisasi (tubektomi/vasektomi)**: permanen, sehingga konseling harus matang dan ada persetujuan tertulis (praktik di Indonesia: persetujuan pasangan juga diminta).
4. **Rahasia kedokteran**: hasil tes HIV, IMS, riwayat aborsi, atau kehamilan remaja **wajib dirahasiakan**; dibuka hanya untuk kepentingan pasien, perintah hukum, atau atas izin pasien.

3. Aborsi: Data dan Definisi

3.1 Data di Indonesia (slide)

1. Sekitar **2,4 juta kasus aborsi setiap tahun** di Indonesia (data BKKBN, slide).
2. **29,1%** dilakukan oleh **remaja / akibat kehamilan tidak diinginkan (KTD)**, dengan **lebih dari 4.000 kasus kekerasan seksual per tahun** (slide).
3. **Paradoks klinis** (slide): angka KTD dan kekerasan seksual tinggi, tetapi **± 74% masyarakat Indonesia menolak legalisasi aborsi**.
4. Akibatnya banyak aborsi dilakukan **diam-diam dan tidak aman**, dan klinik ilegal tetap marak (slide berita "Aborsi Dilegalkan, Klinik Ilegal Tetap Marak").





Dari slide. Kiri: lanskap epidemiologi aborsi di Indonesia (2,4 juta kasus per tahun; 29,1% oleh remaja/KTD; mayoritas masyarakat menolak legalisasi). Kanan: berita bahwa klinik aborsi ilegal tetap marak meskipun aturan pengecualian sudah ada. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan)**: kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki saat itu. **BKKBN**: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

3.2 Definisi klinis abortus (slide)

1. **Abortus**: **berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan**, yaitu **usia gestasi < 20 minggu** atau **berat janin < 500 gram** (WHO/Williams, slide).
2. **Klasifikasi** (slide):

Jenis	Keterangan
Abortus spontan	**Terjadi alami (keguguran)**, tanpa tindakan
Abortus provokatus	**Disengaja / diinduksi**
↳ **Provokatus kriminalis**	**Tanpa indikasi medis, ilegal, tidak aman**
↳ **Provokatus medisinalis / terapeutikus**	**Dengan indikasi medis, legal, aman**; fokus bahasan kuliah ini (slide)



Dari slide: taksonomi abortus. Kriteria klinis usia gestasi < 20 minggu atau berat janin < 500 g. Abortus dibagi spontan dan provokatus; provokatus dibagi kriminalis (tanpa indikasi medis, ilegal, tidak aman) dan medisinalis/terapeutikus (indikasi medis, legal, aman). *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Di Indonesia, batas viabilitas sering dipakai **22 minggu / 500 g** dalam beberapa pedoman. Untuk soal etik, pegang definisi dosen: **< 20 minggu atau < 500 g**.

4. Aborsi: Aspek Hukum

4.1 Legal vs ilegal (slide)

Legal (terapeutik) (slide)	**Ilegal (kriminal) (slide)**
Ada **indikasi kedaruratan medis** atau **kehamilan akibat perkosaan**	Dilakukan oleh **tenaga yang tidak kompeten**
Kompetensi dokter/tenaga kesehatan terjamin	**Cara non-medis**: jamu, pijat, ramuan tradisional
Persetujuan tertulis tim kelayakan (minimal 2 tenaga ahli)	**Dengan atau tanpa persetujuan** ibu hamil/suami
Ada **persetujuan ibu hamil dan/atau suami**	**Dokter kompeten tetapi tanpa indikasi medis**
Dilakukan di **fasilitas kesehatan berstandar yang diakui** (ditunjuk Menteri)	

1. Aborsi legal **hanya sebagai tindakan terapeutik**, dan **tidak semua** keadaan yang punya indikasi medis otomatis boleh diaborsi (slide).
2. **Peringatan** (slide): **dokter yang melakukan aborsi tanpa indikasi medis tergolong tindakan ilegal dan malapraktik, meskipun ia kompeten secara klinis**.

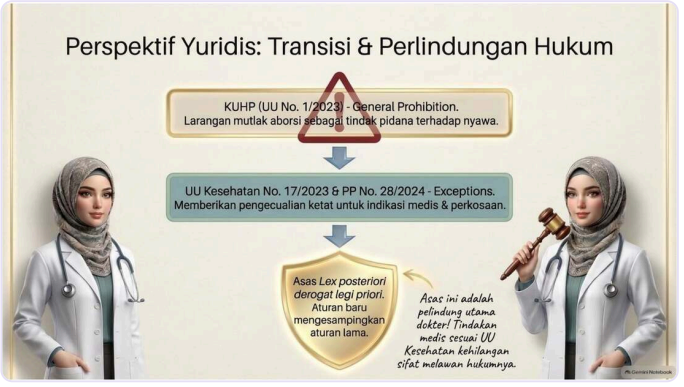


Dari slide: matriks hukum legal vs ilegal. Legal: indikasi medis/perkosaan, dokter kompeten, persetujuan tertulis tim (minimal 2 ahli), persetujuan ibu/suami, fasilitas berstandar. Ilegal: tenaga tidak kompeten, cara non-medis, tanpa persetujuan, atau dokter kompeten tanpa indikasi medis. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

4.2 Perjalanan aturan (dari lama ke baru)

Aturan	Isi pokok tentang aborsi
UU 23/1992 (lama, slide)	Pasal 15: "Dalam keadaan **darurat** sebagai upaya **menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya** dapat dilakukan **tindakan medis tertentu**." Istilah "aborsi" tidak disebut
UU 36/2009 (slide)	Pasal 75 ayat 1: "**Setiap orang dilarang melakukan aborsi**." Ayat 2: **pengecualian** untuk (a) **kedaruratan medis** sejak usia dini kehamilan, yang **mengancam nyawa ibu dan/atau janin**, atau janin dengan **penyakit genetik berat / cacat bawaan** yang **tidak dapat diperbaiki** sehingga sulit hidup di luar kandungan; (b) **kehamilan akibat perkosaan** yang menimbulkan **trauma psikologis**
PP 61/2014 (pelaksana UU 36/2009)	Aborsi korban perkosaan hanya **sebelum usia kehamilan 40 hari (± 6 minggu) dihitung dari HPHT**
UU 17/2023 tentang Kesehatan (berlaku, menggantikan UU 36/2009)	Pasal 60: setiap orang dilarang melakukan aborsi, **kecuali** dengan kriteria yang dikecualikan dalam **KUHP** (indikasi kedaruratan medis atau korban perkosaan/kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan)
PP 28/2024 (pelaksana UU 17/2023)	Mengatur teknis pengecualian: **kedaruratan medis** dan **korban perkosaan maksimal 14 minggu**, tim kelayakan, fasilitas yang ditunjuk
KUHP baru (UU 1/2023, berlaku 2 Januari 2026)	**Pasal 463**: aborsi dilarang dan dipidana; **tidak dipidana** bila korban **perkosaan/kekerasan seksual** dengan **usia kehamilan ≤ 14 minggu**, atau ada **indikasi kedaruratan medis**





Dari slide. Kiri: anatomi hukum, pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi, dengan dua pengecualian (kedaruratan medis dan korban perkosaan maksimal 14 minggu), serta sanksi tambahan bagi tenaga medis (Pasal 429). Kanan: transisi hukum dari larangan umum KUHP ke pengecualian UU Kesehatan 17/2023 dan PP 28/2024; asas lex posterior derogat legi priori. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

📖 **Kamus kecil**

HPHT: Hari Pertama Haid Terakhir, titik awal menghitung usia kehamilan. **Lex posterior derogat legi priori** (slide): asas hukum "aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama" untuk hal yang sama. **Lex specialis derogat legi generali**: aturan khusus mengesampingkan aturan umum. **PP**: Peraturan Pemerintah, aturan pelaksana undang-undang. **KUHP**: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⭐ **Penting**

Menurut slide, asas lex posterior adalah **pelindung utama dokter**: **tindakan medis yang sesuai UU Kesehatan kehilangan sifat melawan hukumnya**. Artinya aborsi yang memenuhi syarat pengecualian **bukan tindak pidana**.

4.3 Dua pengecualian menurut PP 28/2024 (slide)

	Kedaruratan medis	**Kehamilan akibat perkosaan**
Kriteria utama	**Mengancam nyawa/kesehatan ibu**, ATAU **cacat bawaan janin yang tidak memungkinkan hidup (incompatible with life)**	**Korban tindak pidana perkosaan/kekerasan seksual** yang menyebabkan kehamilan
Batas usia gestasi	**Bergantung evaluasi medis** (tidak ada batas pasti)	**Maksimal 14 minggu dihitung dari HPHT**
Syarat khusus	**Persetujuan suami/keluarga**	**Tidak wajib persetujuan suami**, tetapi **butuh keterangan penyidik (kepolisian)** tentang dugaan perkosaan, dan surat keterangan dokter tentang usia kehamilan



Dari slide: pengecualian legal berdasarkan PP 28/2024. Kedaruratan medis: mengancam nyawa/kesehatan ibu atau cacat janin incompatible with life, batas usia bergantung evaluasi medis, perlu persetujuan suami/keluarga. Perkosaan: maksimal 14 minggu dari HPHT, tidak wajib persetujuan suami, perlu keterangan penyidik. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

⚠️ **Jebakan soal**

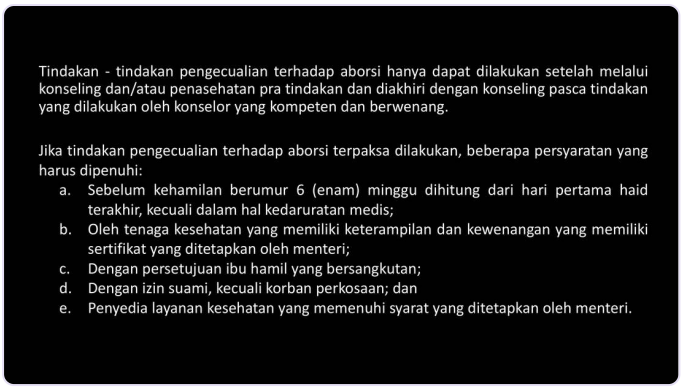
Batas 14 minggu untuk korban perkosaan sangat ketat dan mengikat (slide). Pada soal: korban perkosaan hamil **16 minggu → tidak memenuhi syarat** aborsi legal. Aturan lama (PP 61/2014) memakai **40 hari**, sehingga korban praktis **hanya punya ± 12 hari** setelah telat haid untuk menyadari kehamilan, mengurus visum dan surat polisi, dan mencari fasilitas (slide "polemik batas waktu"). Itulah salah satu alasan batasnya diperpanjang menjadi 14 minggu.

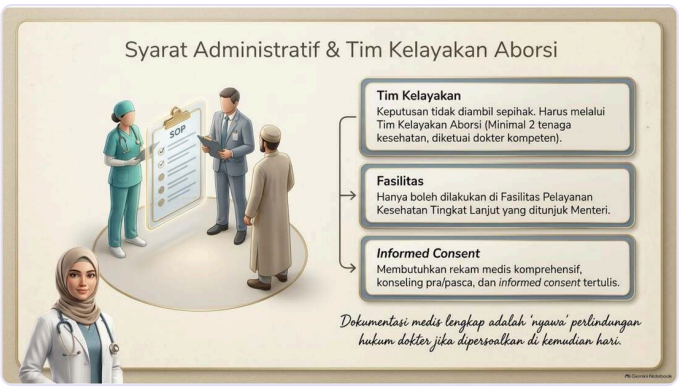


Dari slide: polemik batas waktu aturan lama. Batas 40 hari dari HPHT, padahal siklus haid normal 28 hari, sehingga korban hanya punya sisa ± 12 hari untuk menyadari kehamilan, visum, surat keterangan, dan mencari fasilitas aman. Akibatnya tenaga medis sering takut bertindak meskipun kriteria klinis terpenuhi. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

4.4 Syarat pelaksanaan (slide)

1. **Konseling pra-tindakan dan pascatindakan** oleh **konselor yang kompeten dan berwenang** (slide). Tujuannya agar keputusan bukan karena emosi atau paksaan.
2. Dilakukan oleh **tenaga kesehatan yang punya keterampilan dan kewenangan** (bersertifikat).
3. **Persetujuan ibu hamil** yang bersangkutan; **izin suami, kecuali korban perkosaan** (slide).
4. **Fasilitas** yang memenuhi syarat dan **ditunjuk Menteri** (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut) (slide).
5. **Tim kelayakan aborsi** (slide): keputusan **tidak diambil sepihak**, minimal **2 tenaga kesehatan**, diketuai dokter yang kompeten.
6. **Informed consent tertulis dan rekam medis lengkap** (slide). Slide menekankan: **dokumentasi medis yang lengkap adalah "nyawa" perlindungan hukum dokter** bila kelak dipersoalkan.





Dari slide. Kiri: pengecualian hanya dilakukan setelah konseling pra- dan pascatindakan, dengan persyaratan usia kehamilan, tenaga bersertifikat, persetujuan ibu, izin suami kecuali perkosaan, dan fasilitas yang ditetapkan menteri. Kanan: syarat administratif: tim kelayakan aborsi (minimal 2 tenaga kesehatan), fasilitas tingkat lanjut yang ditunjuk menteri, dan informed consent tertulis dengan rekam medis lengkap. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

4.5 Sanksi pidana (slide)

1. **UU 36/2009 Pasal 194** (slide): setiap orang yang sengaja melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan dipidana **penjara paling lama 10 tahun** dan **denda paling banyak Rp1 miliar**.
2. **UU 17/2023 Pasal 427–429** (aturan sekarang):
    1. **Pasal 427**: **perempuan** yang melakukan aborsi di luar kriteria pengecualian: penjara paling lama **4 tahun**.
    2. **Pasal 428**: **orang yang melakukan aborsi pada perempuan** di luar kriteria: dengan persetujuan perempuan itu paling lama **5 tahun**, tanpa persetujuan paling lama **12 tahun**; bila perempuan meninggal, hukumannya lebih berat.
    3. **Pasal 429** (slide): bila pelakunya **tenaga medis/tenaga kesehatan**, **pidananya ditambah sepertiga** dan dapat dijatuhi **pencabutan hak** (misalnya izin praktik), selain sanksi etik profesi.

5. Aborsi: Sudut Pandang Etika dan Klinis

5.1 Etika Islam: maqasid al-syari'ah (slide)

1. **Maqasid al-syari'ah**: lima tujuan syariat, yaitu menjaga **agama (hifz al-din)**, **jiwa (hifz al-nafs)**, **akal (hifz al-aql)**, **keturunan (hifz al-nasl)**, dan **harta (hifz al-mal)**.
2. **Garis waktu** (slide):
    1. **120 hari (± 17 minggu)**: **nafkh al-ruh (peniupan ruh)**, batas penting dalam fikih Islam.
    2. **20 minggu**: **batas viabilitas medis** (janin < 500 g).
3. **Prinsip hifz al-nafs (menjaga nyawa)** (slide):
    1. **Nyawa ibu bersifat yaqin** (sudah pasti dan nyata).
    2. **Nyawa janin bersifat ihtimal** (masih potensial).
    3. Bila keduanya bertentangan, **syariat mendahulukan keselamatan jiwa ibu**.
4. Hukum aborsi **bervariasi sebelum 120 hari**, tetapi **setelah 120 hari haram mutlak kecuali nyawa ibu terancam (kedaruratan medis)** (slide). Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 membolehkan aborsi karena **darurat medis** atau **perkosaan** sebelum 40 hari.



Dari slide: perspektif etika Islam (maqasid al-syari'ah) dan garis waktu kehamilan: 120 hari (peniupan ruh) dan 20 minggu (batas viabilitas medis). Prinsip hifz al-nafs: nyawa ibu yaqin, nyawa janin ihtimal, sehingga keselamatan ibu didahulukan bila terjadi konflik. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Fikih**: ilmu hukum praktis dalam Islam. **Yaqin**: pasti, nyata. **Ihtimal**: kemungkinan, belum pasti.
> **Fatwa**: pendapat hukum agama dari ulama/lembaga berwenang (di Indonesia: MUI).

5.2 Patofisiologi aborsi tidak aman (slide)

Komplikasi (slide)	Mekanisme
Perdarahan (hemorrhage)	**Perdarahan masif** karena **sisa konsepsi tertinggal** atau **trauma jalan lahir**
Sepsis	**Syok septik** karena **prosedur tidak steril**, sering memicu **kegagalan organ ganda**
Perforasi uterus	**Trauma langsung** pada organ panggul akibat **alat tajam (kuretase ilegal)**, bisa melukai usus dan kandung kemih

1. Lainnya: **keracunan** jamu/ramuan, **emboli udara**, **infertilitas** (perlengketan rahim / sindrom Asherman, tuba tersumbat), dan **trauma psikologis**.
2. **WHO**: aborsi tidak aman adalah salah satu **penyumbang utama Angka Kematian Ibu (AKI)** (slide). Inilah alasan negara ikut mengatur.



Dari slide: patofisiologi aborsi ilegal (abortus kriminalis): perdarahan masif, sepsis karena prosedur tidak steril, dan perforasi uterus akibat alat tajam. Aborsi tidak aman termasuk penyumbang utama AKI. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

5.3 Contoh kasus dari slide

5.3.1 Kasus (slide)

1. **Ny. A, 28 tahun, G2P1A0**, usia kehamilan **10 minggu**.
2. Diagnosis: **gagal jantung dekompensasi berat (NYHA IV)**, terus memburuk meskipun terapi obat maksimal.

3. Prognosis: melanjutkan kehamilan membawa **risiko kematian ibu > 50%**.
4. **Dilema**: mengakhiri kehamilan atau kehilangan nyawa ibu?

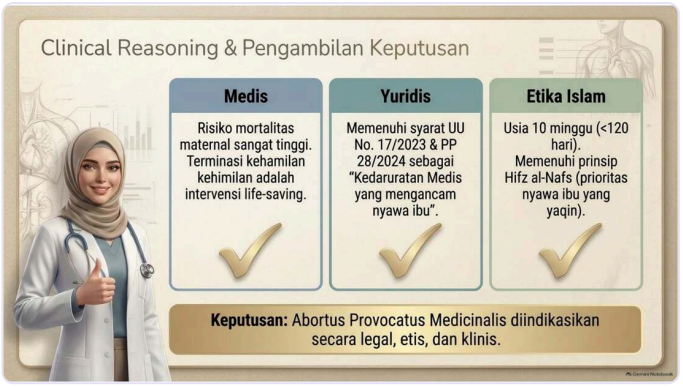
> 📖 **Kamus kecil**
>
> **G2P1A0**: gravida 2 (hamil kedua kalinya, termasuk sekarang), para 1 (pernah melahirkan 1 kali), abortus 0. **NYHA IV**: kelas paling berat gagal jantung menurut New York Heart Association; sesak bahkan saat istirahat. Kehamilan menambah volume darah ± 40–50% sehingga jantung yang sudah gagal makin terbebani.

5.3.2 Penalaran klinis tiga sisi (slide)

Medis (slide)	Yuridis (slide)	Etika Islam (slide)
Risiko kematian ibu sangat tinggi; **terminasi kehamilan adalah intervensi penyelamat nyawa (life-saving)**	Memenuhi syarat **UU 17/2023 dan PP 28/2024** sebagai **kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu**	Usia 10 minggu (< 120 hari); memenuhi prinsip **hifz al-nafs** (nyawa ibu yang yaqin didahulukan)

Keputusan (slide): **abortus provokatus medisinalis diindikasikan secara legal, etis, dan klinis**. KDB yang dominan: **beneficence** untuk ibu dan **otonomi** ibu setelah konseling.





Dari slide. Kiri: kasus Ny. A, 28 tahun, hamil 10 minggu dengan gagal jantung NYHA IV dan risiko kematian > 50%. Kanan: penalaran klinis dari sisi medis, yuridis, dan etika Islam, yang ketiganya mendukung abortus provokatus medisinalis.
Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026

5.3.3 Prinsip tatalaksana (slide)

1. **Metode farmakologis**: **misoprostol ± mifepriston** (slide). Pilihan utama untuk **usia kehamilan awal**, meniru proses abortus spontan. (Mifepriston adalah antiprogesteron; misoprostol adalah analog prostaglandin E1 yang membuat rahim berkontraksi dan serviks melunak.)
2. **Metode instrumental**: **aspirasi vakum manual (AVM / MVA)** atau evakuasi medis, dengan **pengawasan ketat anestesi dan hemodinamik** (slide). AVM lebih aman daripada kuret tajam.
3. **Pemantauan pascatindakan**: **observasi perdarahan**, **pencegahan infeksi (antibiotik profilaksis)**, dan **stabilisasi tanda vital** (slide). Tawarkan **kontrasepsi pascaaborsi**.
4. **Tindakan hanya setelah persetujuan Tim Kelayakan Aborsi** (slide).



Dari slide: prinsip tatalaksana aborsi medisinalis: metode farmakologis (misoprostol ± mifepriston), metode instrumental (aspirasi vakum manual), dan pemantauan pascatindakan; dilakukan setelah persetujuan tim kelayakan. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

5.4 Aspek psikologis: hifz al-aql (slide)

1. Aborsi medisinalis, terutama karena **kelainan janin berat atau perkosaan**, memicu **trauma psikologis berat** (slide).
2. **Peran dokter** (slide):
    1. **Wajib menyediakan konseling pra- dan pascatindakan**.
    2. **Mencegah keputusan emosional atau paksaan pihak luar**.
    3. Sejalan dengan **hifz al-aql (menjaga akal/mental)**: melindungi kesehatan mental ibu dari kerugian (dharar) jangka panjang.
3. Pesan slide: **kesehatan reproduksi bukan hanya soal organ, tetapi juga kesejahteraan jiwa pasien**.

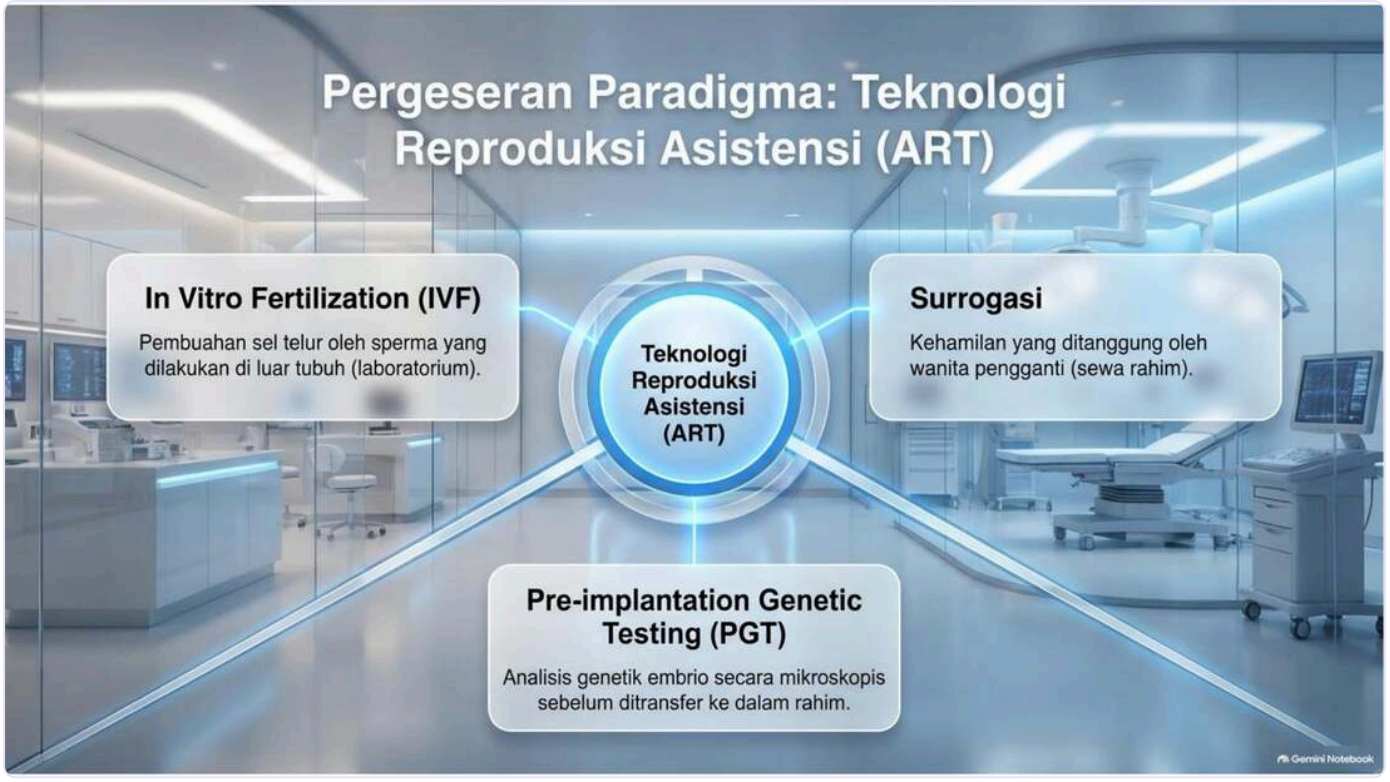


Dari slide: aspek psikologis dan konsep hifz al-aql. Dokter wajib memberi konseling pra- dan pascatindakan, mencegah keputusan emosional atau paksaan, dan melindungi kesehatan mental ibu. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

6. Teknologi Reproduksi Berbantu (ART)

6.1 Pergeseran paradigma (slide)

Teknologi (slide)	Arti
IVF (In Vitro Fertilization) / bayi tabung	**Pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh (di laboratorium)**, lalu embrio dimasukkan ke rahim
Surogasi	**Kehamilan yang ditanggung oleh perempuan pengganti (sewa rahim)**
PGT (Pre-implantation Genetic Testing)	**Analisis genetik embrio secara mikroskopis sebelum ditransfer ke rahim**

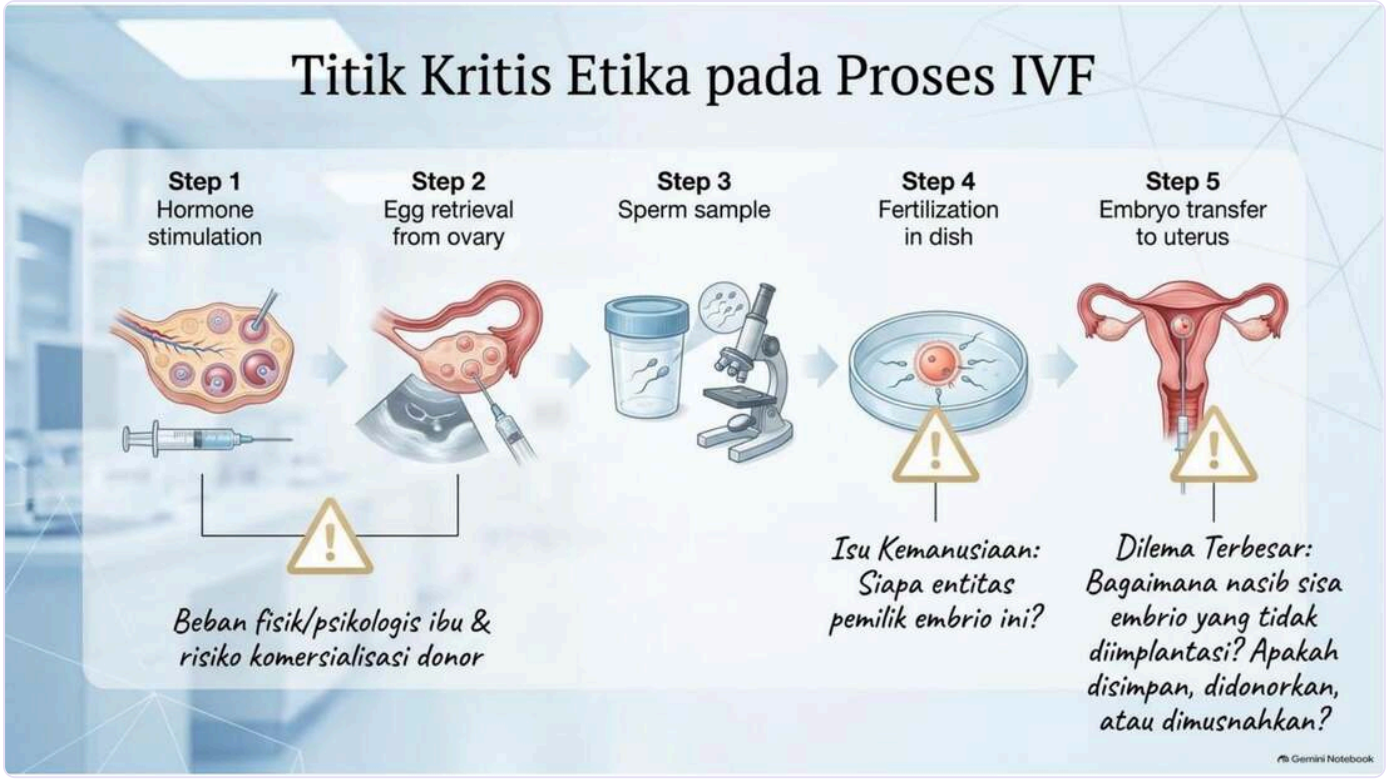


Dari slide: pergeseran paradigma teknologi reproduksi asistensi (ART), yaitu IVF, surogasi, dan pre-implantation genetic testing (PGT). *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

6.2 Titik kritis etika pada proses IVF (slide)

Tahap (slide)	Isu etika
1. **Stimulasi hormon**	**Beban fisik/psikologis ibu** (suntikan, risiko sindrom hiperstimulasi ovarium)
2. **Pengambilan sel telur** dari ovarium	Risiko **komersialisasi donor** (jual-beli sel telur)
3. **Sampel sperma**	Asal sperma (suami vs donor)

Tahap (slide)	Isu etika
4. **Pembuahan di cawan**	**Isu kemanusiaan: siapa pemilik embrio ini?**
5. **Transfer embrio ke rahim**	**Dilema terbesar: nasib embrio sisa yang tidak ditanam**, disimpan, didonorkan, atau dimusnahkan?



Dari slide: lima langkah IVF dan titik kritis etikanya: beban fisik/psikologis ibu dan komersialisasi donor, status kepemilikan embrio, serta nasib embrio sisa yang tidak diimplantasi. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

6.3 Aturan ART di Indonesia (tambahan)

1. **UU 17/2023 (Pasal 58)** dan **PP 61/2014 / Permenkes 43/2015**: reproduksi dengan bantuan atau di luar cara alamiah **hanya untuk pasangan suami istri yang sah** yang mengalami infertilitas.
2. **Sel telur dan sperma harus dari pasangan suami istri itu sendiri**, dan **embrio ditanam dalam rahim istri asal sel telur**.
3. Akibatnya: **donor sperma, donor sel telur, dan surogasi (sewa rahim) tidak diperbolehkan** di Indonesia. Ini sejalan dengan fatwa MUI tentang bayi tabung (boleh bila dari suami-istri sah dan ditanam di rahim istri).
4. **Pemilihan jenis kelamin** tidak boleh, **kecuali** untuk mencegah **penyakit genetik terkait jenis kelamin** (misalnya hemofilia).
5. Embrio sisa boleh **dibekukan (kriopreservasi)** untuk kehamilan berikutnya pasangan yang sama, dengan persetujuan tertulis dan batas waktu.

6.4 Tantangan global (slide)

1. **Kesenjangan dan akses** (slide): **kemiskinan dan diskriminasi struktural** membuat kelompok marginal tidak punya akses adil ke teknologi reproduksi canggih (bayi tabung mahal) → masalah **keadilan**.
2. **Kloning vs penyuntingan gen** (slide): mayoritas negara **melarang kloning manusia**. **Modifikasi genetik** masih **area abu-abu**: ada potensi **menghapus gen penyakit mematikan**, tetapi ada ketakutan **eugenika** (**"designer babies"**, bayi yang dirancang sesuai keinginan).



Dari slide: tantangan etika global, yaitu kesenjangan akses teknologi reproduksi dan perdebatan kloning vs penyuntingan gen (risiko eugenika / designer babies). *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

📖 **Kamus kecil**

Eugenika: upaya "memperbaiki" keturunan manusia dengan memilih sifat genetik tertentu; secara sejarah dipakai untuk diskriminasi. **Kriopreservasi**: penyimpanan sel/embrio dalam suhu sangat dingin (nitrogen cair). **Sindrom hiperstimulasi ovarium (OHSS)**: ovarium membengkak dan cairan berpindah ke rongga perut akibat obat stimulasi.

6.5 Studi kasus area abu-abu (slide)

Kasus (slide)	Dilema	Penjelasan (slide)
1. Surogasi (sewa rahim)	**Otonomi vs kontrak**	Hak otonomi perempuan pengganti atas tubuhnya (termasuk hak menghentikan kehamilan) **berbenturan tajam** dengan hak kontraktual pasangan yang memesan bayi
2. Seleksi embrio (PGT)	**Beneficence vs justice**	Tujuan baik: **mencegah penyakit genetik berat sejak dini**; tetapi berisiko etis **menyisihkan embrio yang "tidak sempurna"**, yang berpotensi memicu **diskriminasi disabilitas sejak awal kehidupan**



Dari slide: studi kasus area abu-abu bioetika. Kasus 1 surogasi (otonomi vs kontrak). Kasus 2 seleksi embrio dengan PGT (beneficence vs justice). *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

7. Solusi dan Pesan Bawa Pulang

7.1 Pendekatan holistik multipihak (slide)

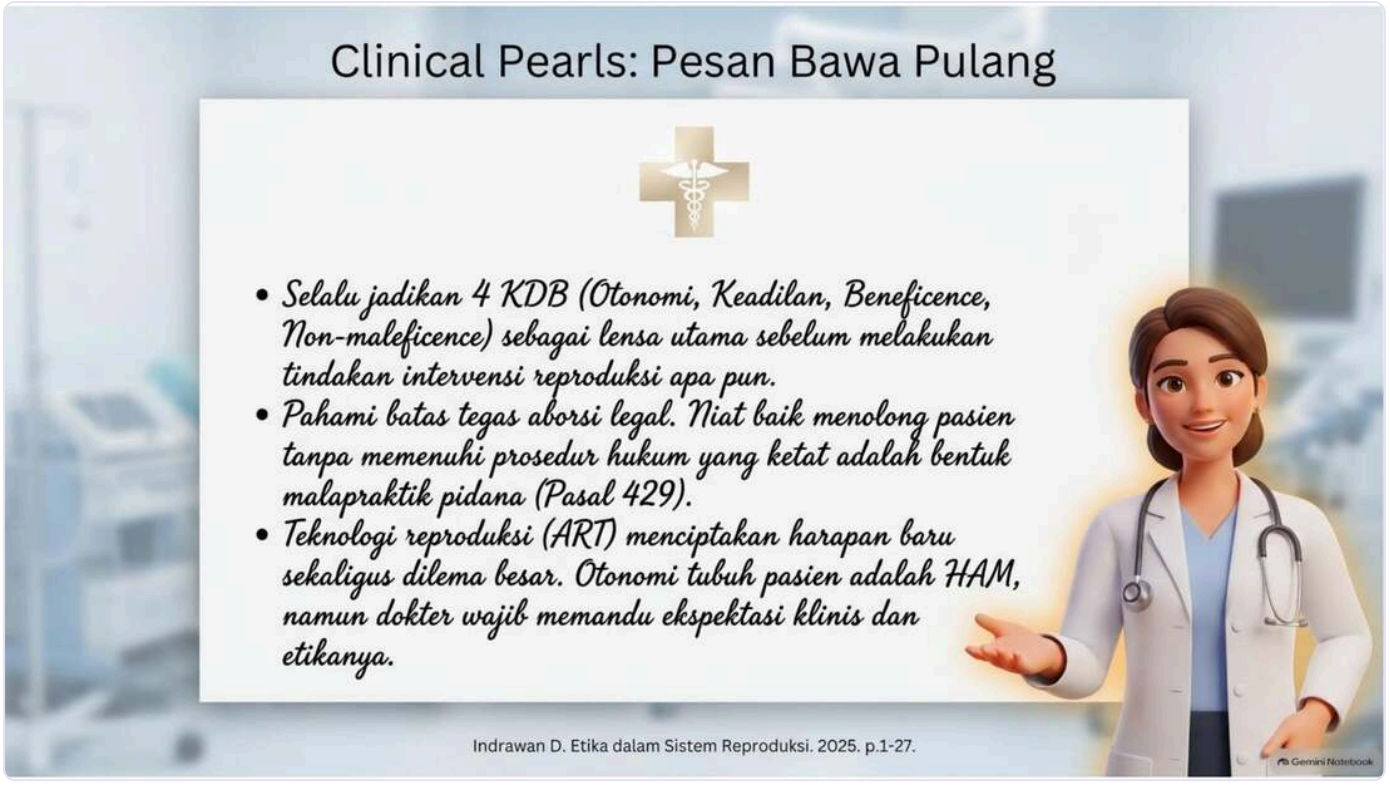
1. **Medis dan agama**: menyelaraskan inovasi teknis dengan pandangan moral/spiritual tentang awal mula kehidupan.
2. **Hukum**: membuat regulasi yang seimbang, melindungi hak individu, dan meminimalkan eksploitasi.
3. **Komite etik rumah sakit**: melibatkan dialog multipihak (dokter, ilmuwan, agamawan, pakar hukum) untuk keputusan yang sulit.
4. **Edukasi**: meningkatkan literasi masyarakat tentang batasan dan hak reproduksi.



Dari slide: solusi etis melalui pendekatan holistik multipihak: medis dan agama, hukum, komite etik rumah sakit, dan edukasi masyarakat. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

7.2 Clinical pearls (slide)

1. **Selalu jadikan 4 KDB (otonomi, keadilan, beneficence, non-maleficence) sebagai lensa utama** sebelum melakukan intervensi reproduksi apa pun.
2. **Pahami batas tegas aborsi legal**. **Niat baik menolong pasien tanpa memenuhi prosedur hukum yang ketat adalah bentuk malapraktik pidana (Pasal 429)**.
3. **Teknologi reproduksi (ART) menciptakan harapan baru sekaligus dilema besar**. Otonomi tubuh pasien adalah HAM, tetapi **dokter wajib memandu ekspektasi klinis dan etikanya**.



Dari slide: clinical pearls, yaitu 4 KDB sebagai lensa utama, batas tegas aborsi legal (niat baik tanpa prosedur = malapraktik pidana), dan ART sebagai harapan sekaligus dilema. *Sumber: PPT KUL 12 Etika Kesehatan Reproduksi 2026*

8. Video YouTube Pendukung

Video di bawah sudah dicek judul dan kanalnya. Tonton sebagai pelengkap, bukan pengganti slide dosen.

Topik	Video	Kanal
Kaidah dasar bioetika, Prof. Agus Purwadianto	Kaidah Dasar Bioetika bersama Prof. Agus Purwadianto	Etika & Hukum Dalam Bidang Kesehatan
Empat prinsip etika medis (ringkas)	Medical Ethics 2 - The Four Principles - Prima Facie Autonomy, Beneficence, NonMaleficence & Justice	JHP Medical UK
Informed consent (FK Unsoed)	Informed Consent (Kelompok 9 - Biomedical Ethics 2020)	Fakultas Kedokteran UNSOED Official
Struktur PP 28/2024 sebagai aturan pelaksana UU 17/2023 (PKMK UGM)	DISKUSI #1: Tentang Struktur PP No.28 tahun 2024 sebagai Peraturan Pelaksana UU No.17 tahun 2023	PKMK FK-KMK UGM
PP 28/2024 dan aborsi korban perkosaan (berita)	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Tuai Kontroversi · Liputan 6	Liputan6
Etika teknologi reproduksi berbantu (ART)	Ethics In Assisted Reproductive Technology	Corlandos Scott
Dilema embrio sisa program bayi tabung	Abandoned Embryos From Fertility Treatment Create Ethical Dilemma · TODAY	TODAY

9. Ringkasan

1. **Kesehatan reproduksi** = sehat **fisik, mental, sosial** utuh, bukan sekadar bebas penyakit; lingkupnya prakonsepsi, hamil, persalinan, pascapersalinan, kontrasepsi.
2. **4 KDB**: **otonomi** (hak memilih, informed consent, rahasia), **beneficence** (manfaat terbaik), **non-maleficence** (primum non nocere), **keadilan** (akses merata). Bila bertabrakan, pakai **prima facie** sesuai konteks.
3. **Abortus**: berakhirnya kehamilan **< 20 minggu / < 500 g**; **spontan** vs **provokatus** (kriminalis vs medisinalis/terapeutikus).
4. **Aturan**: dasar = **setiap orang dilarang aborsi**. Pengecualian **(1) kedaruratan medis** (nyawa/kesehatan ibu terancam, atau janin cacat berat incompatible with life; batas usia sesuai evaluasi medis; persetujuan suami/keluarga) dan **(2) korban perkosaan ≤ 14 minggu dari HPHT** (tanpa wajib izin suami, perlu keterangan penyidik). Aturan lama: **40 hari**.
5. **Syarat**: konseling pra/pasca, **tim kelayakan minimal 2 tenaga ahli**, tenaga bersertifikat, **fasilitas yang ditunjuk Menteri**, **informed consent tertulis + rekam medis lengkap**.
6. **Sanksi**: perempuan 4 tahun, pelaku 5–12 tahun (UU 17/2023); **tenaga medis + sepertiga dan pencabutan hak (Pasal 429)**; aturan lama 10 tahun dan Rp1 miliar.
7. **Etika Islam**: **120 hari** (peniupan ruh); **nyawa ibu (yaqin) didahulukan** atas janin (ihtimal) → **hifz al-nafs**; perhatikan mental ibu → **hifz al-aql**.
8. **Aborsi tidak aman**: **perdarahan, sepsis, perforasi uterus**; penyumbang utama AKI.
9. **ART di Indonesia**: hanya **suami-istri sah**, **gamet sendiri**, **ditanam di rahim istri**; donor gamet dan **surogasi dilarang**; seleksi jenis kelamin hanya untuk penyakit terkait kromosom seks. Isu: pemilik dan nasib **embrio sisa**, **PGT vs diskriminasi disabilitas**, **kloning dan designer babies**, **keadilan akses**.